

a6_task_pack 测试报告

生成时间：2026-05-08 20:13:35

测试时间：2026-05-08 20:13:35

- 一、测试目的：验证工具增强对输出质量提升作用。
- 二、测试内容：同一输入下，分别运行 use_tools=True/False。
- 三、测试方法：对比输出结构与长度，核对产物路径。
- 四、测试过程：
 - 1) 启用工具运行；
 - 2) 禁用工具运行；
 - 3) 指标对照；
 - 4) 结论归纳。

五、测试结果：

启用工具 success=True chars=1456 markers=32

禁用工具 success=True chars=1045 markers=19

工具说明：tool_风险洞察:tool_风险洞察：从长者智能计算图提取历史参考证据

tool_照护洞察:tool_照护洞察：从长者智能计算图提取历史参考证据

tool_个性化健康档案:tool_个性化健康档案：从长者智能计算图提取历史参考证据

tool_体征洞察:tool_体征洞察：从长者智能计算图提取历史参考证据

tool_用药洞察:tool_用药洞察：从长者智能计算图提取历史参考证据

六、结论：工具可显著提升智能体输出准确性、完整性与专业性，助力机构提供更精准照护与医疗服务。

【启用工具输出摘录】

返院适应期专项任务包

长者姓名：陈萍忠

适用阶段：出院后返院适应期（建议执行周期：2-4周）

制定依据：ECR状态对比报告（住院前→出院后）及个性化照护需求

一、用药管理任务

服务内容：

- 每日早晚各1次系统性用药核查，确保按时、按量服用包括多奈哌齐、美金刚、瑞舒伐他汀钙片等处方药物。
- 核对药物名称、剂量、服用时间，防止漏服、错服或重复给药。
- 观察服药后反应（如嗜睡、胃肠道不适），记录并反馈异常。

频次：每日2次（建议时间：08:00、20:00）

> *依据：最新信息明确要求“用药核查每日2次”；历史用药记录显示药物种类多、存在重复录入风险，需强化核查以保障依从性与安全性。*

二、跌倒防护任务

****服务内容**：**

1. ****晨间防跌倒巡视****：每日早晨检查居室环境，移除地面障碍物，确保防滑垫铺设到位，扶手稳固。
2. ****行动辅助****：平地行走时提供部分身体支撑或使用助行器，禁止独自行走。
3. ****洗澡全程协助****：照护员全程陪护，调节水温，使用防滑座椅，避免烫伤与滑倒。
4. ****夜间如厕陪护****：鉴于既往夜间跌倒史，建议夜间如厕由照护员陪同。

****频次**：**

- 晨间防跌倒巡视：每日1次（建议时间：07:30）
- 行动辅助与洗澡协助：按需执行（每日至少1次洗澡，行走活动视日程安排）
- 夜间如厕陪护：每晚按需执行

> *依据：最新信息指出“平地行走需部分辅助、洗澡需全程协助”及“照护重点为跌倒防护”；历史记录证实有夜间如厕跌倒事件，需针对性干预。*

三、认知非药物干预任务

****服务内容**：**

- 开展“舞蹈认知干预”活动，结合长者跳舞喜好，通过节奏训练、简单舞步模仿、音乐回忆等方式，刺激记忆、注意力与执行功能。
- 活动设计需简短（15–20分钟/次）、结构化、情绪正向，避免引发抗拒。
- 若出现拒绝行为，采用柔性引导（如先播放其喜爱音乐），不强制参与。

****频次****：每周5次（建议安排在上午精神状态较好时段，如09:30–10:00）

> *依据：最新信息明确要求“舞蹈认知干预每周5次”并提及“跳舞喜好”；历史记录显示BPSD导致康复依从性低，故强调非强制、兴趣导向策略。*

四、家属支持任务

****服务内容**：**

- 定期与家属沟通照护进展、长者情绪变化及任务执行情况。
- 提供照护技巧指导（如如何应对拒绝行为、安全协助洗澡等）。
- 缓解家属焦虑，鼓励其参与非药物干预（如共同听音乐、简单互动）。

****频次****：每周2次（建议固定时间，如周二、周五下午）

> *依据：最新信息明确“家

【禁用工具输出摘录】

返院适应期专项任务包

****长者姓名****：陈萍忠

****适用阶段****：出院后返院适应期（建议覆盖前4周）

****制定依据****：ECR状态对比报告（住院前→出院后）及照护需求评估

一、用药管理任务

服务内容：

- 核对当日医嘱药品种类、剂量、服用时间；
- 确保按时服药，观察有无漏服、误服或不良反应；
- 针对BPSD症状，避免强制给药，采用温和引导方式（如结合日常活动提醒）。

频次：每日2次（建议早、晚各1次，与餐时或固定作息绑定）

二、跌倒风险防控任务

服务内容：

- 晨间全面巡视：检查床边无障碍物、地面干燥、助行器就位、防滑垫完好；
- 行走时提供部分身体支撑，避免催促或拉拽；
- 洗澡时段安排专人全程协助，确保浴室防滑措施启用；
- 穿着防滑鞋，裤腿长度适中，避免绊倒。

频次：晨间防跌倒巡视每日1次（建议07:00 – 08:00）

三、认知非药物干预任务

服务内容：

- 开展结构化舞蹈认知干预：选用老人熟悉的轻快音乐，融入简单重复动作，结合节奏训练与社交互动；
- 每次干预时长控制在20 – 30分钟，避免疲劳；
- 利用其“跳舞喜好”提升参与意愿，减少BPSD抗拒行为；
- 干预后给予积极反馈，强化正向体验。

频次：每周5次（建议周一至周五上午进行，避开午休）

四、健康监测任务

服务内容：

- 测量静息状态下血压，记录数值并观察有无头晕、面色异常等表现；
- 数据异常时及时上报医护人员；
- 监测过程保持环境安静，减少老人紧张情绪。

频次：每日1次（建议上午09:00左右）

五、家属支持与沟通任务

服务内容：

- 向家属反馈老人当日情绪、配合度、活动参与情况；
- 指导家属应对BPSD的沟通技巧（如避免否定、使用简单指令）；
- 缓解照护焦虑，提供喘息支持信息；
- 鼓励家属参与舞蹈干预环节（如远程视频共舞），增强情感联结。

频次：每周2次（建议周二、周五下午进行，每次15 – 20分钟）

备注：

- 所有任务执行需尊重老人意愿，避免强制；
- 若BPSD症状加剧（如攻击性、游走），立即启动应急预案并联系医疗团队；
- 本任务包将根据后续评估动态调整。